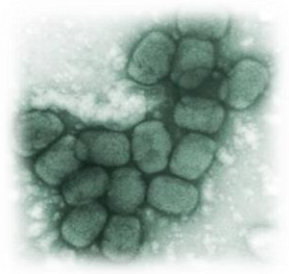
Mpox
¿Qué debes saber?

Farmacéuticos
Consejo General de Colegios Farmacéuticos

Versión 20 agosto 2024



¿Qué se sabe?

En el año 2022 se produjo un brote global de mpox (anteriormente denominada "viruela del mono"), una enfermedad infecciosa causada por el virus de la viruela símica. Desde entonces, se han registrado alrededor de 100000 casos y 208 muertes en 116 países, si bien se sospecha que estas cifras pueden estar infraestimadas debido a deficiencias en los sistemas de vigilancia, especialmente en países en desarrollo de África.

En España, hasta agosto de 2024 se han notificado unos 8100 casos, de los cuales 7521 corresponden al año 2022, aproximadamente el 93 % del total. Aunque en nuestro país la incidencia en los dos últimos años ha sido baja, la transmisión de una nueva variante (el clado 1b) ha crecido en los últimos meses en determinadas zonas de África, principalmente en la República Democrática del Congo.

Este aumento de los casos ha motivado, como ya ocurrió en 2022, la declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la OMS.

¿Qué es la mpox?

Es una infección causada por un virus de la familia *Poxviridae*, del género *Orthopoxvirus*, en el que también se encuentra el virus de la "viruela humana"; aunque tuvo su origen en monos, los primeros casos en humanos se describieron en 1970. Se trata de una enfermedad endémica de zonas de selva en África oriental y central (Congo, Nigeria, etc.) que se contagia entre humanos por contacto estrecho cuando hay intercambio prolongado de fluidos de vías respiratorias o lesiones cutáneas. Por ahora no puede considerarse como una enfermedad de transmisión sexual.

Tras un periodo de incubación de aproximadamente 7 a 14 días (a veces, hasta 21), los síntomas iniciales son: fiebre, intenso dolor en la cabeza, de articulaciones y musculares (típicamente en la espalda), inflamación de los ganglios linfáticos y cansancio. El signo más característico es una erupción cutánea con picor asociado, que aparece tras 1-3 días, con ampollas que evolucionan hasta convertirse en pústulas y costras que se caen; suele empezar en la cara y se disemina a otras partes del cuerpo, incluyendo manos y pies y los genitales.

La enfermedad suele ser autolimitada y desaparece en 2-4 semanas. La OMS subraya que su tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas epidemias y se estima entre el 1 % y el 10 % según la variante.

Consideraciones desde la Farmacia:

- En 2022, se autorizó en la UE un antiviral oral específico llamado *tecovirimat*, pero no se ha comercializado todavía en España.
- En cuanto a su prevención farmacológica, actualmente se cuenta con la vacuna Imvanex® (vacuna viva modificada de la viruela vacunoide Ankara), que se administra en determinados centros en todas las Comunidades Autónomas. Por ahora, la vacuna solo se recomienda como profilaxis preexposición a determinados grupos de la población, como a las personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo o a personas con riesgo ocupacional, como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS. También se puede administrar como profilaxis posexposición a las personas que hayan tenido un contacto estrecho con una persona contagiada.
- Para el control de brotes, se recomiendan las siguientes medidas preventivas:
    - Los casos sospechosos o con síntomas compatibles deben buscar atención médica y aislarse en sus domicilios. Sus contactos estrechos deben minimizar las interacciones sociales y vigilar la posible aparición de síntomas. La notificación de casos es importante.
    - Proteger especialmente a niños y jóvenes, que en principio podrían tener una enfermedad más grave por no haber estado expuestos al virus ni a la antigua vacuna de la viruela humana.
    - Evitar contacto con animales que puedan ser vectores del virus (especialmente aquellos que tengan sintomatología o vivan en áreas endémicas) o cualquier material en contacto con ellos.
    - Buena higiene de manos con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas tras el contacto con personas o animales infectados.
    - Minimizar las prácticas sexuales de riesgo (por ejemplo, muchas parejas sexuales).
    - Podría llegar a usarse la vacuna de la viruela humana en contactos estrechos o personas de riesgo, antivirales e inmunización pasiva con inmunoglobulinas.
- Se recuerda una vez más que los antibióticos no son eficaces para el tratamiento de infecciones virales, y su uso inadecuado puede favorecer resistencias antimicrobianas.

Más información y entrevistas:
914312560 / comunicacion@redfarma.org / https://www.farmaceuticos.com